

NOTULEN

HARI / TANGGAL : KAMIS / 19 FEBRUARI 2026
 PUKUL : 14.00
 AGENDA RAPAT : RAPAT SOSIALISASI MANAJER OPERASIONAL

PEMIMPIN RAPAT : dr. SEFRINA TRISADI, Sp.DVE
 NOTULIS : ADINDA LESTARI PUTRI, S.KM
 TEMPAT : LOKASI DINAS MASING MASING

Berikut hasil notulen :

NO	POKOK BAHASAN	MASALAH	TINDAK LANJUT	PIC
1.	Manajer Operasional	UTW	1. Operasional harian (alur pelayanan, jadwal SDM, sistem antrian dan koordinasi antar unit 2. Kendali biaya → biaya OP, BMHP, Produktivitas 3. Monitoring Kinerja 4. Koordinasi Lintas Fungsi 5. Kepatuhan administrasi dan regulasi	Direksi PT, Manajer SDM PT
		Perbedaan dengan Kepala klinik	Kepala klinik 1. Fokus pada medis 2. Membawahi seluruh staf medis Manajer operasional 1. kendali mutu dan biaya 2. membawahi staf non medis Tapi tetap saling berkolaborasi keduanya	Direksi PT, Manajer SDM PT, Kepala Klinik

		SOTK	1. Akan ada garis Koordinasi antara Kepala klinik dan manajer operasional. 2. Koordinator Klinik → akan di ganti dan di hapuskan 3. Manajer operasional → diusahakan masing masing 1 untuk MS	Direksi PT, Manajer SDM PT, Kepala Klinik
		Saran dan Masukan	1. Manajer operasional diharapkan paham terkait regulasi regulasi BPJS → Bisa kaderisasi dari koordinator klinik yg sekarang dan by target untuk calon manajer operasional yang baru 2. Untuk tenaga administrasi → akan di breakdown terlebih dahulu tupoksinya dan di koordinasikan dengan SDM apakah bisa di rangkapkan dengan jobdesk lain 3. Humas marketing a. Akan di fokuskan tupoksi nya dan by target b. Program kerja PT kedepannya Humas Marketing untuk masing masing MS 4. Pemetaan manajer operasional akan di rapatkan oleh direksi dan manajerial PT → focus saat ini hanya sosialisasi agar masing masing klinik sudah mengetahui terkait Manajer Operasional 5. Manajer operasional diharapkan dapat berfokus pada program tidak hanya pelayanan 6. Wawancara manajer operasional nantinya akan melibatkan Kepala Klinik	Direksi PT, Manajer SDM PT, Kepala Klinik

2.	Keterlambatan dokter	1. Pemotongan gaji untuk Dokter a. Dokter sudah izin setiap terlambat b. Yang menjadi catatan adalah dokter yang bersangkutan selalu izin. 2. Batas waktu terlambat untuk dokter → apakah bisa di pertimbangkan beberapa menit setelah pelayanan di buka	1. Tetap berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk pemotongan gaji bagi dokter yg terlambat, perlu ada evaluasi dan kedisiplinan. a. evaluasi dari tenaga dokter maupun dari IKS dengan BPJS untuk kemudian di mediasikan dengan BPJS b. Mengkaji ulang evaluasi kinerja dokter dan seluruh staff dengan komponen profesionalisme (mencakup ketepatan waktu) c. Bila setelah ditekankan mengenai SE keterlambatan masih menolak dipotong / protes, saran tidak dilanjutkan dan rekrut dokter baru 2. Sudah ada batas keterlambatan → 11 menit	Direksi PT, Manajer SDM PT, Kepala Klinik
----	----------------------	---	---	---

Pemimpin Rapat



dr. Sefrina Trisadi, Sp.DVE

Malang, 19 Februari 2026
Notulis

Dokumen ditandatangani secara elektronik. Gunakan Pembaca Tandatangani Elektronik Untuk Verifikasi Dokumen Ini

Adinda Lestari Putri, S.KM